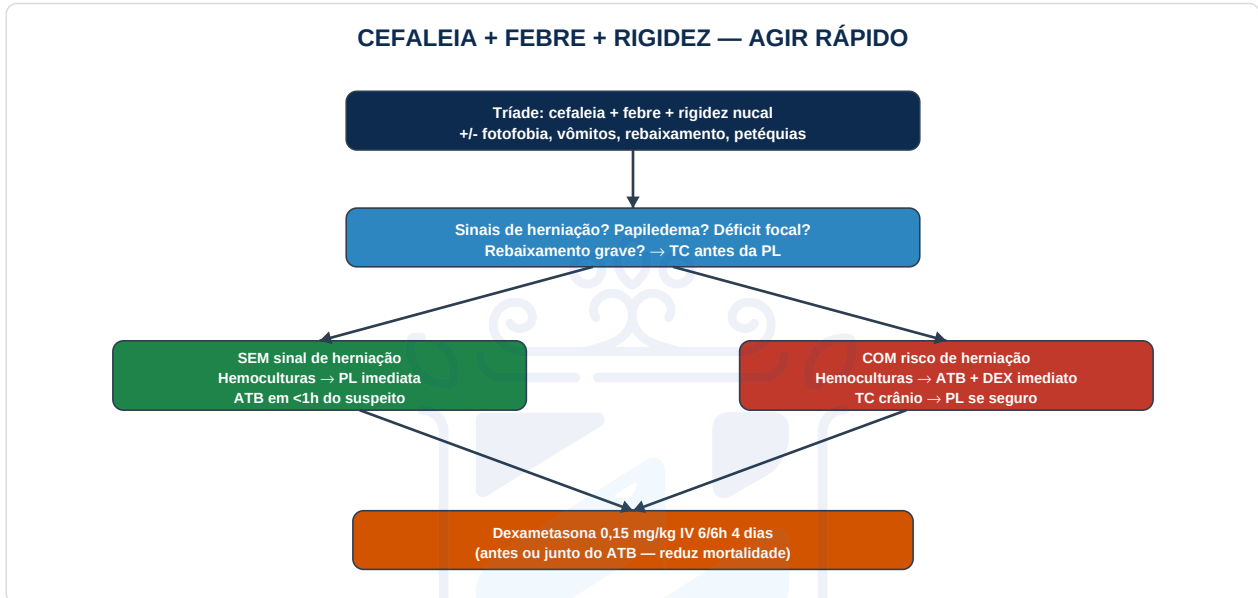


MENINGITE — ATB ATÉ 1H + DEXAMETASONA

ABORDAGEM INICIAL — SUSPEITA DE MENINGITE



ANÁLISE DO LCR — PADRÕES

Parâmetro	Normal	Bacteriana	Viral	TBC/Fúngica
Pressão (mmH2O)	<180	>250	>200	↑↑ (cripto)
Células	<5 (linf)	>1.000 (PMN)	10-500 (linf)	10-500 (linf)
Proteína (mg/dL)	15-45	>100 (até 1.000)	50-100	>100
Glicose	≥60% glicemia	<40 (<45%)	Normal	<45%
Lactato LCR	<3,5 mmol/L	>3,5	Normal	>3,5
Gram/cultura	—	Positivo 60-90%	PCR viral	BAAR, tinta china

ANTIBIOTICOTERAPIA EMPÍRICA — ADULTO

Cenário / Idade	Esquema empírico	Cobertura
18-50 anos, imunocompetente	Ceftriaxona 2g IV 12/12h + Dexametasona 0,15mg/kg 6/6h	S. pneumoniae, N. meningitidis
<1 mês ou >50 anos	Ceftriaxona + Ampicilina 2g IV 4/4h + Dexametasona	+ Listeria monocytogenes
Imunossuprimido / HIV	Ceftriaxona + Ampicilina + Vancomicina + Dexametasona	+ Listeria, Cryptococcus
Pós-neurocirurgia / trauma	Meropeném 2g IV 8/8h + Vancomicina 15-20 mg/kg 12/12h	MRSA, Gram-neg resistente
Herpes (encefalite)	Aciclovir 10 mg/kg IV 8/8h por 14-21 dias	HSV-1/2 (PCR LCR positivo)

ENCEFALITE — DIFERENCIAL DA MENINGITE

QUANDO SUSPEITAR DE ENCEFALITE

- Rebaixamento de consciência (confusão, letargia, comportamento bizarro) + febre
- Déficit focal, afasia, hemiplegia, crises epiléticas + febre (meningite não causa focal)
- RMC-crânio: hipersinal em lobos temporais (HSV-1 — encefalite herpética mais comum)
- EEG: atividade epileptiforme ou lentificação focal
- LCR: pleocitose linfocítica, proteína leve, glicose normal; PCR HSV
- Encefalite autoimune (Anti-NMDA): jovem, psicose + movimentos anormais + disautonomia — anti-NMDAR sérico/LCR

MENINGOCÓCICA — EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA

Reconhecer Meningococcemia

- Petéquias (50%) + púrpura fulminante = alarme
- Início súbito, evolução em horas para choque
- Coagulação intravascular disseminada (CIVD)
- ATB IMEDIATO (não aguardar TC/PL): ceftriaxona
- Notificação compulsória imediata
- Quimioprofilaxia de contatos: rifampicina 600mg 12/12h x 2 dias

Meningite Tuberculosa

- Evolução subaguda (dias-semanas); imunocomprometido
- LCR: glicose muito baixa, proteína alta, linf, ADA elevada
- RMC: hidrocefalia, realce meníngeo basal, tuberculomas
- BAAR no LCR (sensibilidade 40%); PCR TB
- Tratamento: RIPE 12 meses + dexametasona obrigatória
- Mortalidade alta se diagnóstico tardio

CHECKLIST — MENINGITE BACTERIANA NO PS

NÃO ATRASAR O ATB

- ☐ Tríade (cefaleia + febre + rigidez): suspeita ativa — agir em minutos
- ☐ Hemoculturas 2 pares → PL se sem contraindicação (sem TC de espera)
- ☐ ATB + Dexametasona em <1h do diagnóstico (cada hora aumenta mortalidade)
- ☐ Contraindicações à PL sem TC: papiledema, déficit focal, Glasgow <13, coagulopatia
- ☐ Herpes: aciclovir 10 mg/kg IV se qualquer suspeita de encefalite (esperar PCR do LCR)
- ☐ UTI: choque, rebaixamento, Glasgow <13, ventilação mecânica se necessário
- ☐ Notificação: meningocócica, pneumocócica, H. influenzae = compulsória

SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Paciente de 25 anos com febre, cefaleia intensa e rigidez de nuca, sem papiledema nem déficit focal. Qual é a sequência CORRETA?

- A) TC crânio → PL → ATB + Dexametasona
- B) Hemoculturas → PL → ATB + Dexametasona em até 1h
- C) ATB → PL → Dexametasona
- D) PL → TC → ATB se bacteriana confirmada
- E) Anti-inflamatório oral + observação 24h

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual é o padrão típico do LCR na meningite bacteriana aguda?

- A) Pleocitose linfocítica, glicose normal, proteína levemente elevada
- B) Pleocitose neutrofílica >1.000 cels, glicose <45%, proteína >100 mg/dL
- C) LCR xantocrômico com glicose normal
- D) LCR hemorrágico com eritrócitos crenados
- E) LCR cristalino com proteína <30 mg/dL

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Por que a dexametasona deve ser iniciada ANTES ou junto com o antibiótico na meningite bacteriana?

- A) Para cobrir infecção fúngica associada
- B) Para reduzir a inflamação meníngea antes da lise bacteriana, diminuindo mortalidade e sequelas (especialmente surdez)
- C) Para diminuir a pressão intracraniana imediatamente
- D) Para melhorar a penetração do antibiótico no SNC
- E) Para prevenir o choque anafilático ao ATB

QUESTÃO 4

SES-SP / Adaptada

Paciente com meningococemia: febre alta, petéquias difusas e choque. Qual é a conduta prioritária?

- A) Aguardar PL antes de iniciar ATB
- B) TC de crânio urgente para guiar a PL
- C) Ceftriaxona IV imediatamente, antes de qualquer exame diagnóstico
- D) Vancomicina + meropeném como primeira escolha
- E) Corticoide isolado enquanto aguarda hemocultura

QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

Paciente com rebaixamento de consciência, febre e RMC mostrando hipersinal em lobo temporal. Qual é o diagnóstico mais provável e o tratamento?

- A) Meningite bacteriana — ceftriaxona 2g IV
- B) AVC hemorrágico — reversão de anticoagulação
- C) Encefalite herpética (HSV-1) — aciclovir 10 mg/kg IV 8/8h
- D) Abscesso cerebral — meropeném + metronidazol
- E) Síndrome anti-NMDA — plasmaférese

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Sem papiledema e sem déficit focal: não há contraindicação à PL imediata. Sequência: hemoculturas → PL → ATB + Dexametasona em até 1h. TC antes da PL retarda ATB e só é obrigatória se papiledema, déficit focal ou Glasgow ≤ 12 .

QUESTÃO 2 → Resposta: B

Meningite bacteriana: pleocitose PMN >1.000 células/mm³, hipoglicorraquia ($<45\%$ da glicemia), hiperproteínorraquia >100 mg/dL, lactato $>3,5$ mmol/L. Gram + em 60-90% não tratados. Viral: linfocítica, glicose normal.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Dexametasona antes/junto do ATB reduz a liberação de citocinas inflamatórias após lise bacteriana, diminuindo mortalidade e sequelas neurológicas (especialmente surdez por *S. pneumoniae*). Perder o benefício se dado após ATB.

QUESTÃO 4 → Resposta: C

Meningococcemia com choque = emergência máxima. Ceftriaxona IMEDIATAMENTE, sem aguardar PL ou TC. Cada hora sem ATB aumenta mortalidade. Hemoculturas podem ser tentadas mas não devem atrasar o ATB. Notificação compulsória.

QUESTÃO 5 → Resposta: C

Hipersinal temporal no RMC + febre + confusão = encefalite herpética (HSV-1) até prova em contrário. Tratamento: aciclovir 10 mg/kg IV 8/8h por 14-21 dias. PCR HSV no LCR confirma. Iniciar aciclovir sem aguardar resultado.

SM24
Suporte ao Plantão Médico